

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Η πολιτική μας στο πεδίο των εξαρτήσεων

Το πρόβλημα της εξάρτησης από τοξικές ουσίες, αλκοόλ και όλα τα νέα αντικείμενα εξάρτησης (τζόγος, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο κ.α) θέτει στο επίκεντρο την έννοια και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, τόσο για την ερμηνεία των αιτιών και των παραγόντων που συμβάλλουν στην εξάρτηση όσο και για την επίλυσή της .

Ως κοινωνική πολιτική για τα ναρκωτικά μπορούμε να ορίσουμε το αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης θεσμών, δομών, ομάδων και ατόμων. Όλα αυτά μαζί εμπλέκονται στην διαμόρφωση και στην εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής μέσα σε ένα κοινωνικό–ιστορικό πλαίσιο.

Η διαμόρφωση και εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής στηρίζεται στην ισχυρή λειτουργία ενός κράτους πρόνοιας σε όλη την σφαίρα της ψυχικής υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το πρόβλημα της εξάρτησης προσδιορίζεται και ερμηνεύεται συχνά ως ένα πρόβλημα ψυχολογικό, ιατρικό, πολιτικό, κοινωνικό. Είναι κάτι από αυτά ή είναι όλα μαζί ;

Με βάση την διεθνή εμπειρία και την βιβλιογραφία η εξάρτηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο δυναμικό και σε διαρκή εξέλιξη καθώς δεν υπάρχει ένα στατικό, αμετάβλητο προφίλ του ανθρώπου που κάνει χρήση ουσιών. Για αυτό κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών θεραπευτικών προτάσεων, η ύπαρξη ενός θεραπευτικού πλουραλισμού, ώστε ο χρήστης να μπορεί να βρει το πλαίσιο που θα λειτουργήσει θεραπευτικά για εκείνον, σε μια δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα.

Σε διεθνές επίπεδο, οι πολιτικές κινούνται διαχρονικά ανάμεσα στην ανοχή και την καταστολή, μια προσπάθεια με κίνητρα αλλά και με κυρώσεις, γεγονός που τοποθετεί ερμηνευτικά την εξάρτηση ως ένα ζήτημα δημόσιας υγείας.

Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης από την έναρξη της δεκαετίας του 2000 η ερμηνεία αυτή έγινε πιο ισχυρή καθώς η χρήση ουσιών συνδέθηκε με σοβαρές λοιμώξεις (HIV /AIDS, ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ Β, C). Σε αυτή την βάση προκρίθηκαν και

υποστηρίχθηκαν τα προγράμματα μείωσης της βλάβης (χορήγηση υποκαταστάτων), έναντι της θεραπείας απεξάρτησης (στεγνά προγράμματα).

Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε και να συνδέσουμε την κατεύθυνση αυτή της πολιτικής για τα ναρκωτικά με την ελλειμματική καταγραφή δεδομένων που διαπιστώθηκε για την αποτύπωση του αριθμού των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών. Το Τμήμα Ναρκωτικών κι Εγκλήματος του ΟΗΕ (UNODOC 2013) μας πληροφορεί για

Α. την κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα ανθρώπων που κάνει χρήση και αφορά ηλικίες από 18 έως 25 χρονών,

Β. την αύξηση του αριθμού των ατόμων που έκαναν χρήση την δεκαετία 2010-2019 και την τοποθετεί στην τάξη του 22% (UNODOC 2021) .

Γ. το γεγονός ότι η κάνναβη είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό με 200 εκατομμύρια χρήστες περίπου

Δ. την αύξηση θανάτων από χρήση (οπιοειδή) κατά 41% .

Επίσης, με την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA) γίνεται μέχρι σήμερα μια συστηματική προσπάθεια μέσα από εθνικά δίκτυα να υπάρξει και να δίνει αξιόπιστα δεδομένα , ένα ανοιχτό δίκτυο πληροφόρησης, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ώστε να ορίζονται κάποιοι σημαντικοί στόχοι κοινωνικής πολιτικής.

Αυτοί αποτελούν μέχρι σήμερα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά και μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής

1. **πρόληψη**
2. **έγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση**
3. **μείωση της βλάβης**
4. **θεραπεία**
5. **κοινωνική επανένταξη και απεξάρτηση**
6. **ενισχυμένα κέντρα ασφάλειας για την παράνομη διακίνηση, διανομή και παραγωγή ναρκωτικών**
7. **ανάπτυξη ειδικών θεραπευτικών προγραμμάτων με βάση το φύλο, την ηλικία, προγράμματα μέσα στις φυλακές.**

Στην χώρα μας, επίσης, η εθνική στρατηγική για τα ναρκωτικά ουσιαστικά αναφέρεται με στόχους όπως η βελτίωση της αποτελεσματικότητας δράσεων, η μείωση της ζήτησης, αύξηση στην προσβασιμότητα στα θεραπευτικά προγράμματα, η βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάπτυξη νέων προγραμμάτων. Σε αυτό το σημείο, όμως, τίθεται το ερώτημα **πώς θα υποστηριχθούν όλα αυτά όταν η κοινωνική πολιτική ουσιαστικά καταστρατηγείται και αποσκοπεί στην κοινωνική καταστολή.**

Πρώτη έκφραση αυτής της καταστολής αποτελεί η παρέμβαση στο ΚΕΘΕΑ, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της σημερινής κυβέρνησης η οποία διορίζει τα μέλη του ΔΣ του ΚΕΘΕΑ. Αυτή η πράξη αποτελεί μια ακύρωση της ίδιας της θεραπευτικής φιλοσοφίας και πρακτικής του πρώτου θεραπευτικού οργανισμού που λειτούργησε

στην χώρα με στόχο την απεξάρτηση μέσα από ένα στεγνό, ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα χωρίς υποκατάστατα.

Η δημιουργία του ΕΟΠΑΕ με τον Νόμο 5129/1-8-24, που ψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία μια μέρα πριν κλείσει η Βουλή για θερινές διακοπές, με την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης και τις πολύμηνες αντιδράσεις των θεραπευτικών οργανισμών απεξάρτησης, των ίδιων των θεραπευομένων και των οικογενειών τους, χωρίς την συμφωνία των αρμόδιων επιστημονικών φορέων αποτελεί την πιο αντιπροσωπευτική πρόταση καταστολής .

Με τον ΕΟΠΑΕ καταργήθηκε χωρίς καμία επιστημονική αξιολόγηση και αιτιολόγηση **η βασική έννοια και άξονας κοινωνικής πολιτικής με θεραπευτικό πλουραλισμό**. Καταργήθηκε η αναγκαία για τον χρήστη και την οικογένειά του διαφορετικότητα θεραπευτικών προγραμμάτων ,συγχωνεύθηκε το προσωπικό τους , οι μονάδες τους, διαγράφοντας την ιστορία η οποία καθόρισε την μοναδική ταυτότητα και φιλοσοφία των θεραπευτικών προγραμμάτων.

Άλλαξε τις ονομασίες τους και με αυταρχικές διοικητικές πρακτικές αποδιοργάνωσε θεραπευόμενους, οικογένειες και εργαζόμενους ακυρώνοντας μια **βασική και πολύτιμη για τη θεραπεία συνθήκη, αυτής της θεραπευτικής συνέχειας όπως αυτή εκφράζεται στην θεραπευτική σχέση**.

Όλα αυτά την στιγμή που, σύμφωνα με τα κύρια σημεία της Ετήσιας Έκθεσης του ΕΚΤΕΠΝ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά) του 2024

1 Δεν μας είναι γνωστή ως προς την έκταση και τα χαρακτηριστικά η χρήση ουσιών στον πληθυσμό .

Η τελευταία έρευνα στον γενικό πληθυσμό είχε διενεργηθεί από το ΕΠΙΨΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο για την Ψυχική Υγεία) το 2004. Από την Πανελλήνια Έρευνα για την χρήση ουσιών, άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές και την ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων – μαθητών (ESPAD) που υλοποιεί το ΕΠΙΨΥ ανά τετραετία από το 1984 μέχρι σήμερα, προκύπτει ότι σημαντική μερίδα 16χρονων μαθητών στην χώρα και στην Ευρώπη κάνουν χρήση ουσιών, καταναλώνουν αλκοόλ, καπνίζουν ή και υιοθετούν συμπεριφορές όπως τυχερά παιχνίδια, υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτοντας σε

κίνδυνο την σωματική και ψυχοκοινωνική τους υγεία. Στην Ελλάδα το 2024 όλοι οι παραπάνω δείκτες ήταν αυξημένοι σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης.

2.Εδραιώνονται μεταβολές στην χρήση ουσιών, όπως η αύξηση αριθμού ατόμων που εισέρχονται για θεραπεία με κύρια ουσία χρήσης την κοκαΐνη και άλλα διεγερτικά, τις βενζοδιαζεπίνες, τα νέα συνθετικά ναρκωτικά και παραισθησιογόνα.

3.Αυξάνεται η ζήτηση για θεραπεία (3,567 άτομα το 2022)

4.Αυξάνεται η τάση για πολλαπλή χρήση ουσιών (ποσοστό 77,5% αναφέρει πολλαπλή χρήση ουσιών χωρίς να περιλαμβάνει το αλκοόλ)

5 Αυξάνονται επίσης, η διάθεση συνθετικών ουσιών, τα επίπεδα διάγνωσης των χρηστών με HCV (ηπατίτιδα c) και HIV (aids)

Με βάση όλα τα παραπάνω η αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης οφείλει να εδράζεται στην παράλληλη λειτουργία:

1. της πρωτογενούς πρόληψης
2. της θεραπείας και
3. της κοινωνικής επανένταξης

1. Πρόληψη

Πρόληψη πληθυσμούς που ακόμη δεν έχουν πειραματιστεί με τις ουσίες, με δράσεις που δεν εξαντλούνται στην ενημέρωση

2. Θεραπεία

Θεραπεία με θεραπευτικό πλουραλισμό, με πλήρη ανάπτυξη και υποστήριξη διαφορετικών θεραπευτικών προτάσεων στεγνών προγραμμάτων εστιασμένων

στην ηλικία και το φύλο των εξαρτημένων ατόμων, με τα προγράμματα μείωσης της βλάβης {υποκατάστατα} να αφορούν πολύ συγκεκριμένους πληθυσμούς όπως άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα που έχουν προσπαθήσει πολλές φορές και δεν έχουν καταφέρει να απεξαρτηθούν.

3. Κοινωνική επανένταξη

Κοινωνική επανένταξη με στήριξη για την επαγγελματική αποκατάσταση, την επανασύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα, την καταπολέμηση του στίγματος.

Επίσης, με την ανάπτυξη δομών σωματικής αποτοξίνωσης και την δωρεάν θεραπευτική φροντίδα για όλους όσους έχουν την ανάγκη, την ενίσχυση των προγραμμάτων μέσα στις φυλακές.

Σε αυτούς τους δοκιμασμένους άξονες θα κινηθεί η πολιτική μας στο πεδίο των Εξαρτήσεων, με πρώτη μας ενέργεια την επαναφορά της αυτοτέλειας και υποδειγματικής λειτουργίας των Στεγνών Προγραμμάτων, του ΚΕΘΕΑ και του 18ΑΝΩ, που αποτελούν πρωτοποριακά κερτημένα σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκρότησαν υποδείγματα πραγματικής απεξάρτησης των ανθρώπων, οικοδόμησης στέρεων βάσεων για την αυτεξούσια ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Η κατάργησή τους σηματοδοτεί μια δυσανεξία στην πραγματική απεξάρτηση και μια ροπή προς την πολιτική των υποκαταστάτων, που δεν μπορεί να είναι η μόνη θεραπευτική λύση. Πιστεύουμε βαθιά ότι η έξοδος από τις εξαρτήσεις θα κατακτηθεί μέσα από μία πολιτική που θα στηρίζει τα προγράμματα απεξάρτησης και, στο πλαίσιο του θεραπευτικού πλουραλισμού, να δίνει την διέξοδο και θα δείχνει τον δρόμο για μια πραγματικά χειραφετημένη κοινωνία.